복통 감별진단: 맹장염을 놓치지 않기

초기 맹장염(급성충수염)은 처음부터 오른쪽 아랫배가 딱 아프지 않을 수 있습니다. 명치 불편감, 배꼽 주변 통증, 체한 느낌으로 시작해 시간이 지나며 우측 하복부 통증으로 바뀌는 경우가 있습니다.

우측 하복부 통증과 반발 압통을 확인하세요



몸 기준 오른쪽 아랫배 — 맹장 끝 충수에 생긴 염증

오늘 바로 확인해야 하는 신호

눌렀다 뗄 때 더 아픈 반발 압통이면 성인은 응급실에서 진찰과 CT 등 영상검사 여부를 확인하세요. 누를 때만 아픈 **단순 압통**은 오늘 의원에서 진찰합니다. 소아는 초음파 후 필요 시 CT/MRI로 이어질 수 있습니다.

신호	이렇게 나타납니다
단순 압통	오른쪽 아랫배를 누를 때만 아프고 뗄 때는 더하지 않음 — 오늘 의원 진찰.
반발 압통	진찰에서 '눌렀다 뗄 때 더 아프다(반발 압통)'는 말을 들으면 — 응급실 평가.

통증 지속·악화	동반 증상
장염약·복통약을 먹어도 좋아지지 않고 통증이 계속됩니다.	식욕저하, 구역, 발열, 무기력감이 함께 생길 수 있습니다.

맹장염 통증은 이렇게 시작될 수 있습니다

① 명치·배꼽 주변 불편감	② 구역·식욕저하	③ 우측 하복부로 이동	④ 복막 자극 신호
초기에는 위염·체기처럼 애매한 상복부 불편감으로 느껴질 수 있습니다.	설사가 뚜렷하지 않아도 속이 메스껍고 식욕이 떨어질 수 있습니다.	진행하면 오른쪽 아랫배 압통, 움직임·기침 시 통증이 뚜렷해집니다.	반발 압통, 배가 단단해짐, 통증 악화는 **응급 평가가 필요합니다.**

응급실 영상검사 고려

반발 압통, **배가 단단해짐**, **걷기 어려운 통증**이 있으면 맹장염·복막 자극 여부를 빠르게 확인해야 합니다.

오른쪽 아랫배가 아니어도 의심해야 하는 경우

고령·소아	약 복용 후 지속	다른 복통 원인
통증·열·압통이 약하거나 위치 설명이 어려워 장염처럼 보일 수 있습니다.	일반 장염약·복통약 후에도 통증이 계속되면 같은 날 재평가가 필요합니다.	장염·위염, 요로결석, 담낭 질환, 여성 골반통도 감별이 필요합니다.

진료실 설명 슬라이드(맹장염·게실염 구분) — edu.gwanggyobarun.com/decks/gi/appendicitis-diverticulitis/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — Merck Manual Professional 2024 · ACR RLQ Pain 2022 · AAFP Acute Abdominal Pain 2023

본 안내문은 공통 설명용입니다. 실제 검사 선택과 응급실 방문 여부는 진찰 소견, 나이, 임신 가능성, 기저질환에 따라 달라질 수 있습니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/abdominal-pain-appendicitis-red-flags/